

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

TEST DE RECONOCIMIENTO DE METEDURAS DE PATA (FAUX PAS TEST)

Eje V: Cognición Social y Neurocognición • Teoría de la Mente Avanzada de Baron-Cohen

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Test de Reconocimiento de Meteduras de Pata (Faux Pas Recognition Test).
Nombre Original	Faux Pas Recognition Test (Baron-Cohen, O’Riordan, Stone, Jones & Plaisted, 1999).
Autores Originales	Simon Baron-Cohen, Ph.D., Michelle O’Riordan, Vicki Stone, et al. (Cambridge University).
Adaptaciones Hispanas	Mercadante et al. (2008); García-Molina et al. (2014); Gómez-Pérez et al. (2018).
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Teoría de la Mente (ToM) de segundo orden y cognición social.
Tipo de Instrumento	Prueba neuropsicológica de juicio social heteroaplicada basada en viñetas clínicas.
Composición de Historias	20 historias breves (10 con metedura de pata real y 10 historias control sin error social).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (12 a 85 años); sensible a autismo, DFT y lesión orbitofrontal.
Tiempo de Administración	15 a 20 minutos de lectura compartida y preguntas de comprensión estructuradas.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para investigación científica y práctica asistencial sin fines comerciales.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: LA TEORÍA DE LA MENTE COMPLEJA

El **Faux Pas Test** fue diseñado por el Autism Research Centre de Cambridge para evaluar habilidades de mentalización avanzadas:

- Comprensión de Estados Mentales Dobles:** Una “metedura de pata” ocurre cuando un hablante dice algo sin mala intención, pero que resulta hiriente para el oyente. Detectarlo exige entender simultáneamente dos estados mentales: la creencia y desconocimiento del emisor y el estado emocional de malestar del receptor.
- Superación de Pruebas Básicas:** Supera el efecto techo de las tareas clásicas de falsa creencia (como Sally y Anne), detectando alteraciones sutiles en sujetos con CI normal o superior.
- Sustrato Neuroanatómico Orbitofrontal:** El rendimiento adecuado depende de la integración funcional entre la corteza prefrontal ventromedial/orbitofrontal y el polo temporal, regiones diana en la variante conductual de la Demencia Frontotemporal y el autismo.

3. ESTRUCTURA DE PREGUNTAS POR HISTORIA (SISTEMA DE CALIFICACIÓN)

Dimensión Evaluada	Puntos	Pregunta Clínica y Proceso Cognitivo Explorativo
1. Detección de Faux Pas	1 punto	¿Alguien dijo algo que no debió decir o algo incómodo? (Detección del tropiezo social).
2. Identificación del Emisor	1 punto	¿Quién dijo lo que no debía decir? (Atribución del rol del causante).
3. Naturaleza del Error	1 punto	¿Por qué no debió haberlo dicho? (Comprensión del contenido de la indiscreción).
4. Intención del Emisor	1 punto	¿Sabía la persona que estaba molestando o lo hizo sin querer? (Comprensión de creencia/intención).
5. Empatía con Receptor	1 punto	¿Cómo se sintió la otra persona? (Atribución del impacto emocional en el oyente).
6. Preguntas Control	0 o 1 pt	Preguntas fácticas sobre el relato (comprueba retención atencional básica; no suma a ToM).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Las validaciones clínicas hispanas (García-Molina et al., 2014; Gómez-Pérez et al., 2018; $N > 450$) aportan sólida evidencia:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.84 - 0.88	Alta cohesión psicométrica en la batería de 20 viñetas.
Concordancia Interevaluador	CCI = 0.91 - 0.95	Excelente acuerdo entre examinadores en la corrección de respuestas abiertas.
Sensibilidad en DFTvc	Sensibilidad = 90%	Extraordinaria precisión para detectar atrofia frontal ventromedial precoz.
Discriminación en Autismo	Efecto $d = 1.30 - 1.85$	Separa con gran nitidez personas en el espectro autista de controles típicos.
Validez de Constructo	$r = 0.58$ con RMET (Ojos)	Correlación moderada a alta con otros tests de cognición social y empatía.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- **Puntuación en Historias con Faux Pas (10 Historias):** Se otorgan hasta 5 o 6 puntos por historia (detección, emisor, justificación, intención y empatía). Puntuación máxima: **50 o 60 puntos**.
- **Puntuación en Historias Control (10 Historias):** Se otorga 1 punto si el sujeto reconoce acertadamente que **nadie metió la pata** (rango 0 a 10 puntos; detecta falsos positivos o suspicacia extrema).
- **Direccionalidad Clínica:** A mayor puntuación, mayor madurez en cognición social y mentalización. Puntuaciones deprimidas señalan ceguera mental o insensibilidad social patológica.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntos Faux Pas	Historias Control	Estado de la Teoría de la Mente (Baron-Cohen et al.)
Mentalización Normal	44 a 50 pts	9 a 10 pts	Comprensión óptima de normas sociales sutiles e intenciones ajenas.
Compromiso Leve	36 a 43 pts	7 a 8 pts	Falta ocasional de empatía cognitiva; dificultad en justificar la intención.
Déficit Moderado	26 a 35 pts	5 a 6 pts	Punto de corte clínico alteración evidente de la cognición social.
Déficit Severo	< 26 pts	< 5 pts	Incapacidad de mentalización patrón típico en autismo o DFT.

PUNTO DE CORTE CLÍNICO DISCRIMINANTE (FAUX PAS < 36 PUNTOS):

En adultos sanos, la media poblacional se sitúa entre **44 y 48 puntos sobre 50**. Una puntuación inferior a **36 puntos** (más de 2 desviaciones típicas) refleja un fracaso específico en la atribución de intencionalidad no maliciosa, sugiriendo fuertemente disfunción en la red prefrontal ventromedial o trastorno del neurodesarrollo social.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN EN ALTERACIONES DE CONDUCTA SOCIAL

PROTOCOLO DE VALORACIÓN DE LA COGNICIÓN SOCIAL CON FAUX PAS TEST:

- **Paso 1 (Administración Estándar):** Leer las historias en voz alta permitiendo que el paciente siga el texto impreso para no sobrecargar su memoria de trabajo; formular las preguntas sistemáticas.
- **Paso 2 (Análisis del Tipo de Fallo):**
 - **Fallo en Historias Control (Ve "meteduras de pata" inexistentes):** Típico de hipersensibilidad social, ideas de perjuicio o paranoia; no indica déficit de ToM sino sesgo persecutorio.
 - **Incapacidad de detectar la metedura de pata en historias reales (< 36 pts):** Insensibilidad a la incomodidad social; atribuible a disfunción ventromedial o rasgo del espectro autista.
 - **Detecta la metedura de pata pero cree que fue con mala fe deliberada:** Incapacidad para atribuir falsa creencia / desconocimiento en el emisor.
- **Paso 3 (Orientación Terapéutica):** En autismo o daño frontal, entrenamiento explícito en scripts de cortesía social y desmitificación de malentendidos cotidianos.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: DEMENCIA FRONTOTEMPORAL VARIANTE CONDUCTUAL

Identificación: Varón de 61 años, abogado mercantil en activo, remitido a la Unidad de Neurología tras quejas familiares y profesionales por comentarios groseros en reuniones, pérdida del tacto social y risas inoportunas durante un funeral de un socio. Las pruebas de memoria y lenguaje formal (MMSE 29/30, Barcelona normal) no revelaron ningún deterioro aparente.

Evaluación con el Faux Pas Test (20 Historias):

- **Puntuación en Historias con Metedura de Pata: 16 / 50 puntos (Déficit catastrófico en Teoría de la Mente,** muy inferior al corte de 36 puntos).
- **Detalle del Rendimiento:** En 7 de las 10 historias con metedura de pata afirmó con rotundidad que "nadie había dicho nada inconveniente ni molesto"; en las 3 que detectó, fue incapaz de explicar por qué el oyente se sentía ofendido.
- **Historias Control:** 10 / 10 puntos (comprensión lectora y lógica fáctica rigurosamente conservadas).

Juicio Diagnóstico: Pérdida selectiva y precoz de la Teoría de la Mente afectiva y cognición social. El PET cerebral evidenció hipometabolismo cortical orbitofrontal y prefrontal ventromedial bilateral, confirmando Demencia Frontotemporal variante conductual (DFTvc).

Manejo: Retirada cautelar de responsabilidades jurídicas laborales, tutela financiera y asesoramiento a familiares sobre la naturaleza neurobiológica de la desinhibición.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

SESGO POR MEMORIA DE TRABAJO:

Dejar siempre el texto escrito visible ante el sujeto; si no recuerda la historia por fallo mnésico, cometerá errores falsos en el juicio social.

DISOCIACIÓN AFECTIVA VS. COGNITIVA:

Distinguir sujetos con alexitimia (que no describen emociones ajenas) de psicópatas (que comprenden el error social pero carecen de remordimiento).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Baron-Cohen, S., O'Riordan, M., Stone, V., Jones, R., & Plaisted, K. (1999). Recognition of faux pas by normally developing children and children with Asperger syndrome or high-functioning autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 29(5), 407-418.
2. Stone, V. E., Baron-Cohen, S., & Knight, R. T. (1998). Frontal lobe contributions to theory of mind. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 10(5), 640-656.
3. García-Molina, A., et al. (2014). Valoración de la cognición social en pacientes con daño cerebral traumático mediante el test de las meteduras de pata. *Revista de Neurología*, 58(7), 289-294.
4. Gómez-Pérez, L., et al. (2018). Propiedades psicométricas del Faux Pas Test en adultos hispanohablantes. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 46(3), 89-98.